

EL INVENTARIO MULTIFASICO DE LA PERSONALIDAD DE MINNESOTA (M.M.P.I.)

DESCRIPCIÓN DEL TEST.

El inventario consiste en 550 afirmaciones que el sujeto debe clasificar como Verdaderas o Falsas si es que son aplicables o no a si mismo. En la forma colectiva se han duplicado 16 ítemes con el propósito de facilitar el cómputo mecánico.

Los resultados obtenido corresponden a su puntaje en cuatro Escalas de validez que son No sé, L, F y K y diez Escalas Clínicas que son Hs (Hipocondría), D (Depresión), Hy (Histeria), Pd (Psicopatía), Mf (Masculino – Femenino), Pa (Paranoia), Pt (Psicastenia), Sc (Esquizofrenia), Ma (Hipomanía) y Si (Introversión Social).

Actualmente, considerando la connotación patológica que tienen los nombres de la mayoría de las escalas clínicas y a que ellas demostraron no ser medidas puras de los síndromes señalados por su nombre, se tiende más bien a nombrarlas por un número. Así, Hs se señala como escala 1, D como escala 2, Hy como 3, Pd como 4, Mf como 5, Pa como 6, Pt como 7, Sc como 8, Ma como 9 y Si como 0

ORIGEN Y DESARROLLO DEL TEST.

El Inventario fue creado alrededor de 1943 por Hathaway y McKinley con el objetivo de contar con un instrumento de evaluación que en un solo test pudiera proveer de datos acerca de las áreas más importantes de la Personalidad. Después de probar el test pensaron que podían avanzar, estableciendo a través de él clasificaciones clínicas más precisas derivadas de la Psiquiatría clásica, de tal manera que las escalas del instrumento representarían a cada grupo psiquiátrico proporcionando un diagnóstico. Sin embargo, el test no funcionó así, de tal manera que las puntuaciones altas en una escala no necesariamente significan que el sujeto tenga el síndrome que da nombre a la escala. Lo que si se ha demostrado es que las personas que muestran un cierto perfil poseen características similares.

Para la construcción del test los autores recogieron una gran cantidad de ítemes que obtuvieron de textos psiquiátricos fichas clínicas, informes psicológicos, escalas de actitudes y de su propia experiencia clínica.

Estos ítemes fueron aplicados a un numeroso grupo normal compuesto por personas de muy diversas características, tales como edad, ocupación, estado civil, etc. que no estuvieran en tratamiento psiquiátrico y a grupos de pacientes psiquiátricos que se caracterizaban algunos por tener una preocupación anormal en relación con las funciones de su cuerpo, otros por ser pacientes que mostraban alteraciones depresivas, otros por presentar reacciones de conversión, otros por ser casos de delincuentes que estaban en tratamiento psiquiátrico, otros cuya alteración más característica eran las ideas de autorreferencia, persecutorias y de grandeza, otros que eran pacientes con rasgos obsesivos compulsivos, miedos anormales y sentimientos de culpa, otros por ser pacientes que mostraban apatía, sentimientos bizarros, delirios y/o alucinaciones y autismo y otros que mostraban hiperactividad, excitación emocional y fuga de ideas. De esta forma se desarrollaron ocho escalas clínicas: Hipocondría (Hs), Depresión (D), Histeria (Hy), Desviación Psicopática (Pd), Paranoia (Pa), Psicastenia (Pt), Esquizofrenia (Sc) e Hipomanía (Ma).

Posteriormente se construyeron dos escalas adicionales. La escala de Introversión Social (Si) fue desarrollada por Drake en 1946, seleccionando ítemes del conjunto original que diferenciaban entre estudiantes universitarios que puntuaban por sobre el Percentil 65 y por debajo del Percentil 35 en la escala de Introversión Social del Inventario T-S-E de Minnesota.

La escala Masculino – Femenino (Mf) fue desarrollada en 1956 por Hathaway y McKinley con el propósito inicial de diferenciar entre hombres heterosexuales y homosexuales. Sin embargo, encontraron dificultades

para cumplir este objetivo ya que los ítemes del pool original que diferenciaban entre los dos grupos eran escasos; por ello ampliaron su enfoque, agregando otros ítemes de este pool que diferenciaban entre hombres y mujeres, además de ítemes de otro test.

La construcción de las escalas clínicas sigue la línea empírica o predicción actuarial la que se define como la determinación empírica de regularidades que pueden existir entre los datos específicos entregados por el test y características de la población que se estudia. En este tipo de tests no se supone necesariamente una relación entre el contenido del ítem y lo que se quiere evaluar y la inclusión de un ítem en una escala se establece dependiendo de su capacidad para diferenciar un grupo de otro. Por ello, los ítemes de un test así construido no tienen la exigencia de tener validez de contenido.

Además de estas diez escalas clínicas se desarrollaron a través de métodos estadísticos cuatro escalas, llamadas Escalas de validez que tienen como propósito detectar actitudes desviadas al responder al test y que permiten evaluar lo confiables que son las respuestas del sujeto. Estas escalas son No sé, L, F y K.

Posteriormente se han desarrollado un gran número de escalas adicionales para evaluar las más diversas características de las personas.

APLICACIÓN DEL TEST

Se puede aplicar en forma individual o colectiva y tiene cuatro formas de aplicación:

Cuadernillo de tapas blandas o duras

Consiste en un cuadernillo que contiene impresas en la primera página las instrucciones y en las siguientes las 566 afirmaciones que forman el test. Se le entrega además al sujeto una hoja de respuestas donde el sujeto debe marcar si la afirmación es Verdadera o Falsa al ser aplicada a él. La forma de tapas duras se usa preferentemente para sujetos que responden al Inventario estando en cama y en general con el propósito de proporcionar una base más firme donde escribir, cuando no se dispone de una mesa o escritorio

Tarjetas.

En esta forma cada una de las 550 afirmaciones está escrita en una tarjeta, las que encuentran ordenadas en una caja, que incluye las instrucciones en su tapa. Además esta caja contiene tres tarjetas más grandes con las etiquetas FALSO, VERDADERO Y NO SE.

Esta forma se usa preferentemente en sujetos con capacidad mental y educación limitada, sujetos algo confusos y sujetos con dificultades visuales

Versión grabada en cinta magnética.

En esta forma las afirmaciones están grabadas en una cinta y después de cada una de ellas se produce una pausa en la que se graba la respuesta del sujeto ya sea por sí mismo o por el examinador. Esta forma se usa preferentemente con sujetos analfabetos o con otras incapacidades que no les permite responder al test en las formas ya mencionadas.

FORMAS ABREVIADAS.

Debido a la extensión del tiempo que necesita el sujeto para responder al test, se han desarrollado algunas formas abreviadas de él, las que sin embargo, como cualquier forma abreviada de cualquier test, implican una pérdida de información.

La forma abreviada más aceptada consiste en aplicar sólo aquellos ítemes que forman parte de las Escalas de validez y de las Escalas clínicas básicas. Para este caso, en la forma colectiva se instruye al sujeto para que responda los primeros 366 ítemes y 33 ítemes adicionales que están dispersos en el cuadernillo. Obviamente un procedimiento de este tipo implica dificultades para el sujeto que puede confundirse y para el examinador, ya que si agrupa juntos los ítemes que el sujeto debe responder, debe cambiar algunas plantillas de corrección

INSTRUCCIONES.

Estas son las instrucciones que se usan para la forma de cuadernillo de tapas blandas. Las instrucciones que se dan en las otras formas de administración no son esencialmente diferentes

Este cuestionario consta de un conjunto de afirmaciones y proposiciones numeradas. Lea cuidadosamente cada una de ellas y decida, si aplicada a su persona es VERDADERA o FALSA.

Usted debe marcar sus respuestas en la hoja de respuesta adjunta. Fíjese en el ejemplo que aparece a continuación:

V		X	X	
	1	2	3	4
F	X			X

EJEMPLO DE ÍTEMES CONTESTADOS CORRECTAMENTE

Si aplicada a su caso, la afirmación o frase es VERDADERA o EN GRAN MEDIDA VERDADERA, coloque una X en la parte de arriba, sobre el número del casillero correspondiente. Si por el contrario, es FALSA, o EN GENERAL NO VERDADERA, coloque la X en la parte de abajo, bajo el número del casillero.

Si la afirmación o frase no se aplica o no corresponde a usted o es algo que usted no conoce, no haga ninguna marca en la hoja de respuestas.

Recuerde que usted debe ser sincero consigo mismo y usar su propio criterio. Trate de contestar todas las preguntas y, si es posible, no dejar ningún espacio en blanco. Al marcar la hoja de respuestas, asegúrese que el número de la frase corresponde al número de la hoja de respuestas.

Marque claramente sus respuestas. Borre completamente cualquier respuesta que usted desee cambiar y reemplácela por la que corresponda

NO HAGA NINGUNA MARCA EN ESTE FOLLETO.

RECUERDE: TRATE EN LO POSIBLE DE DAR ALGUNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS FRASES.

SUJETOS A QUIENES SE APLICA EL TEST.

Se aplica a sujetos de 16 años en adelante sin tope de edad en el límite superior, siempre que se mantengan las habilidades de lectura.

Los sujetos deben tener un mínimo de 6 años de escolaridad. Los estudios han mostrado además que las personas con C.I. inferior a 80 presentan problemas para responder solos el Inventario y tienen necesidad de ser asistidos por el examinador

OBTENCIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PUNTAJES

OBTENCIÓN DE LOS PUNTAJES BRUTOS

En las dos formas de cuadernillo el propio sujeto marca sus respuestas en la Hoja de respuestas; en cambio tanto en la forma de Tarjetas como en la forma grabada en cinta magnética el examinador debe traspasar las respuestas del sujeto a una Hoja de respuestas.

Los puntajes brutos, excepto para la escala No sé, se obtienen aplicando la plantillas de cada una de las escalas sobre la hoja de respuestas y contando los ítems que el sujeto ha respondido en la dirección significativa para esa escala. La suma de estos ítems corresponde al puntaje bruto (PB). El puntaje bruto para la escala No sé corresponde al número de ítems que el sujeto no ha respondido ya sea Verdadero o Falso o que ha marcado las dos opciones.

CORRECCIÓN DE LOS PUNTAJES BRUTOS.

Con el propósito de afinar el poder discriminatorio de algunas escalas se ha visto que es necesario agregarles un cierto coeficiente del Puntaje Bruto de la Escala K a los Puntajes Brutos de ellas.

Las Escalas que se corrigen son:

Hs (1) a la que se le agrega 0.5 K

Pd (4) a la que se le agrega 0.4 K

Pt (7) a la que se le agrega 1.0 K

Sc (8) a la que se le agrega 1.0 K

Ma (9) a la que se le agrega 0.2 K

OBTENCIÓN DE LOS PUNTAJES STANDARD.

Una vez que se han obtenido los PB de cada escala se ubican los Puntajes Standard, que están expresados en una Escala T, en la tabla correspondiente. Existen tablas separadas para cada sexo y para puntajes corregidos y no corregidos con K.

TRAZADO DEL PERFIL.

De acuerdo con los puntajes T obtenidos en la forma señalada, se traza el perfil de los resultados del sujeto en la parte indicada en el protocolo.

CODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Consiste en resumir los resultados obtenidos por el sujeto en cifras y signos. Existen dos métodos para hacerlo:

Método de Hathaway

1. Se le asigna un número a cada una de las escalas clínicas. Estos números son los mismos que se señalaron en la descripción del test.
2. Se escribe el número correspondiente a la escala que tenga el T mayor.

3. Se escriben en orden descendente con respecto a T, los números de las escalas que tengan un T mayor que 54.
4. Se escribe un apostrofe (') después del último número que tenga un T de 70 o más.
5. Se escribe un guión (–) después del número de la escala que tenga el T menor siempre que sea inferior a 46
6. Escribir en orden ascendente los números de las escalas cuyos T están entre el de la escala anotada en el paso 5 y 46
7. Algunos autores insertan un apostrofe para separar los valores bajo 40 puntos.
8. Se subrayan las escalas que tengan el mismo T o sólo un punto de diferencia.
9. A la derecha de la codificación de las escalas clínicas se escriben los valores brutos de L, F y K, en este orden, separados por dos puntos (:)
10. Si l es igual o mayor que 10 o si F es igual o mayor que 16, inmediatamente después de la codificación de las escalas clínicas, se escribe un X para indicar que existe la posibilidad de que el perfil no sea válido.

Método de Welsh o Codificación total.

1. Se le asigna un número a cada una de las escalas. Se usan los mismos que se señalaron en el método anterior.
2. Se escriben los números que representan a las escalas en orden descendente respecto a T.
3. Los dígitos que representan las escalas con un T de 90 o más son seguidos de un asterisco (*).
4. Los dígitos que representan escalas con un T entre 89 – 80 son seguidos por comillas ()
5. Los dígitos que representan escalas con un T entre 79 – 70 son seguidos por apostrofe (').
6. Los dígitos que representan escalas con un T entre 69 – 60 son seguidos por un guión (–).
7. Los dígitos que representan escalas con un T entre 59 – 50 son seguidos por una línea oblicua (/)
8. Los dígitos que representan escalas con un T entre 49 – 40 son seguidos por dos puntos (:).
9. Los dígitos que representan escalas con un T entre 39 – 30 son seguidos por el signo de número (#).
10. Cuando dos o más escalas se ubican en el mismo grupo, el signo correspondiente sigue a la escoa de T inferior dentro de ese grupo de puntaje.
11. Cuando dos o más escalas tienen el mismo T o una diferencia de un punto, se subrayan.
12. Las escalas de validez se codifican a la derecha de las escalas clínicas, en la misma forma que estas, considerando sus puntuaciones T.

Ejemplo.

Suponiendo que un sujeto hubiera obtenido los siguientes resultados:

ESCALA	PA	T	ESCALA	PB	T
?	30	50	Pd	16	43
L	3	46	Mf	22	53
F	16	80	Pa	3	35
KI	11	48	Pt	40	85
Hs	17	65	Sc	37	78
D	34	92	Ma	8	28
Hy	18	53	Si	28	53

Según el método de Hathaway sus puntajes quedarían codificados así:

2 7 8 ` 1 - 9 6 ` 4 X 3 : 16 : 11

Según el método de Welsh quedarían codificados así:

2 * 7 8 ` 1 - 3 5 0 / 4 : 6 # 9 F ? / K L :

Una comparación entre los dos métodos señalados permite apreciar las ventajas del método de Welsh. Con este método se obtiene una mayor cantidad de datos acerca del protocolo, se codifican siempre todas las escalas en intervalos más pequeños y regulares y la reconstrucción del perfil a partir de la codificación es posible con un error máximo de 5 puntos. Con el método de Hathaway esta reconstrucción es más inexacta y a veces resulta imposible.

INTERPRETACIÓN.

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS ESCALAS DE VALIDEZ

Escala No sé (?)

El puntaje de esta escala es el número de reactivos que el sujeto ha dejado sin responder. A pesar de que en las instrucciones se les señala a los sujetos que traten de no dejar ningún ítem sin responder, puede ocurrir que se omita responder a alguna de las afirmaciones y que aún en alguna de ellas haya marcado las dos opciones.

Esta no es una escala en sentido estricto ya que no está conformada por un grupo preciso de ítems. Sin embargo se considera una escala de validez en la medida en que la cantidad de ítems que el sujeto deja de responder acorta artificialmente las otras escalas ya que estos quedan excluidos del computo, lo que podría conducir a puntuaciones más bajas en el resto de las escalas. Algunos autores consideran que si un protocolo contiene más de 30 ítems sin responder es un protocolo no válido. Sin embargo, es recomendable que aún cuando el sujeto sobrepase el número máximo esperado, el examinador verifique a cuáles ítems el sujeto ha dejado de responder, ya que puede existir algún área específica a la que el sujeto evita dar respuesta.

Lo normal es que una persona deje entre 1 y 5 ítems sin responder. Con esta puntuación es poco probable que el perfil aparezca distorsionado, aun cuando todos ellos pertenecieran a la misma escala

En cuanto a las características psicológicas asociadas a la falta de respuesta frente a los ítems, se pueden plantear diversas hipótesis interpretativas. Desde luego una cantidad numerosa de respuestas omitidas puede estar determinada por escasa capacidad de comprensión, una pobre habilidad lectora o confusión mental. También puede responder a una actitud defensiva, intencionada o no, que trata de evitar admitir aspectos no deseados de su persona. Las personas indecisas, ambivalentes u obsesivas pueden también no responder a un

número importante de ítems.

Escala L.

Esta formada por 15 ítems que se refieren a actitudes socialmente reprobadas, como sentimientos agresivos, malos pensamientos, pérdida de control y la conformidad, pero en las cuales la mayoría de los individuos normales ha caído alguna vez. El puntaje en esta escala está conformado por la cantidad de Falsos con que el individuo responde a estos ítems.

Es una escala de validez ya que se supone que la actitud con que el sujeto ha respondido a este conjunto de ítems será semejante a la que ha mantenido a lo largo del cuestionario. Por ello puede suponerse que mientras más alta sea la escala L, más baja será la elevación de las escalas clínicas, ya que la negación de características negativas afectará a todo el registro del sujeto.

Los puntajes altos en esta escala señalan un intento más bien burdo e ingenuo de causar buena impresión y por ello son más frecuentes en sujetos con un nivel cultural y educacional más bajo. Esto hace necesario considerar el nivel sociocultural del sujeto al interpretar los puntajes

Los puntajes elevados se asocian también a características psicológicas como escrupulosidad, moralismo, convencionalismo, insight disminuido, conformismo y el uso de mecanismos de negación y represión.

Las puntuaciones bajas permiten suponer que el sujeto ha respondido con franqueza y tiene la suficiente confianza en si mismo como para poder admitir fallas menores y también que se trata de personas naturales y relajadas

Escala F.

Esta formada por 64 ítems que fueron incluidos porque no más del 10% del grupo normativo los responde en la dirección significativa. Se refieren a pensamientos extraños, experiencias peculiares, sentimientos de alienación o aislamiento, creencias contradictorias, etc.

Un puntaje alto en esta escala puede originarse en un patrón desviado de respuesta , como por ejemplo responder al azar, todo verdadero o todo falso Además puede estar determinado por un intento deliberado por aparecer alterado (fake – bad) que entre otras razones puede surgir de la necesidad de recibir atención y ayuda (grito de ayuda). Este mismo conjunto de causas señalado por la elevación de la escala F puede afectar al resto de las escalas y limitar su validez.

Desde el punto de vista psicológico los puntajes altos se asocian a patología psiquiátrica y las elevaciones algo más moderadas en esta escala corresponden a patología neurótica severa, sujetos poco convencionales, jóvenes con crisis de identidad.

Los puntajes muy bajos (44 o menos) pueden indicar una negación de alteraciones o un deliberado falseamiento positivo (fake – good)

Escala K

Esta compuesta por 30 ítems que mostraron discriminar entre sujetos anormales que producían perfiles normales y sujetos normales, agregándole posteriormente un grupo de ítems que permitían diferenciar casos con patología real de aquellos que deliberadamente aparecían perturbados.

Su contenido se refiere a la negación de dificultades en diversos ámbitos como el familiar, con respecto a si mismo, etc. Por ello un puntaje alto en esta escala frecuentemente se asocia con puntuaciones bajas en las

escalas clínicas, que pueden no ser absolutamente válidas. Este efecto se supone que se corrige al agregar proporciones del puntaje bruto de K al puntaje bruto de algunas de las escalas clínicas

Un puntaje alto en esta escala muestra una actitud defensiva de tratar de aparecer más normal, limitado autoconocimiento e insight. Una elevación más moderada supone autoaceptación y una estructura defensiva que le permite al sujeto un funcionamiento eficiente.

Un puntaje bajo en esta escala pueden representar una disminución de la defensividad normal que en ocasiones se asocia a la búsqueda de atención y ayuda y un autoconcepto negativo.

Cuando el puntaje está dentro del promedio. El sujeto mantiene un equilibrio sano entre la autoevaluación positiva y la autocrítica.

La defensividad que expresa la escala K es más sutil y sofisticada que la que muestra la escala L y por lo tanto es mas representativa de sujetos de nivel cultural y educacional más alto. Del mismo modo que en la escala L, en este caso también es necesario tener en cuenta el nivel socio-cultural del sujeto cuando se interpreta su puntaje en esta escala.

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS ESCALAS CLÍNICAS.

Escala 1 (Hipocondría – Hs)

Esta escala está formada por 30 afirmaciones que se refieren a una variedad de quejas que son características de las personas hipocondríacas. Estas personas se caracterizan por una preocupación anormal por sus funciones corporales, la que domina su vida y restringe severamente tanto su actividad como sus relaciones interpersonales. Ello, además, parece corresponder a un rasgo caracterológico más que a una situación transitoria

Los pacientes con enfermedades o alteraciones físicas pueden producir registros con elevaciones moderadas en la escala 1, pero que en todo caso son menores que las que presentan los pacientes que expresan su conflictiva psicológica a través síntomas somáticos, por lo que se puede afirmar que la escala es capaz de diferenciar entre la verdadera enfermedad física y la alteración hipocondríaca.

Además de la preocupación exagerada por su funcionamiento físico, las personas con puntuaciones altas en esta escala se caracterizan por ser egocéntricas, inmaduras, por tener una capacidad de insight disminuida acerca de las bases de sus preocupaciones , por su tendencia a controlar su entorno a través de las quejas somáticas y por el pesimismo.

Además esta escala se correlaciona negativamente con la sofisticación intelectual y la inteligencia.

Las puntuaciones bajas tienen las características opuestas a las señaladas para las puntuaciones elevadas; vale decir que las personas, además de no estar excesivamente preocupadas por el funcionamiento de su cuerpo, son sensibles y optimistas. Si el puntaje es muy bajo, ellas se adecuan bien al mundo pero les falta calidez.

Escala 2 (Depresión – D)

Esta formada por 60 ítemes y pretende evaluar la depresión sintomática que se caracteriza por un estado de ánimo bajo, pérdida de esperanza en el futuro e insatisfacción general con el estado actual.

Como parece medir más bien la depresión reactiva, resulta ser una medida más bien inestable, ya que varía en la medida en que fluctúa el estado de ánimo de la persona. La causa precisa de la depresión no puede ser inferida sólo de la puntuación en la escala y es necesario considerar la elevación de las otras escalas.

En 1955 Harris y Lingoes realizaron un estudio acerca del contenido de los ítemes de algunas de las escalas del inventario. Este estudio mostró que la Escala D posee cinco dimensiones de contenido que son: Depresión subjetiva (D1), Lentitud psicomotora (D2), Mal funcionamiento físico (D3), Lentitud mental (D4) y Cavilación (D5).

Las personas mayores tienden a tener puntuaciones más altas en esta escala que las personas jóvenes.

Los puntajes más bien bajos en esta escala pertenecen a personas descritas como alertas, gregarias y activas.

Escala 3 (Histeria – Hy)

Consta de 60 ítemes y fue construida con el propósito de identificar a aquellas personas que desarrollan síntomas de conversión con el propósito de evadir responsabilidades o evitar conflictos.

Las puntuaciones elevadas se relacionan además con egocentrismo, narcisismo, manipulación y demanda de atención y tendencia a la negación de las dificultades y conflictos. Por ello ha sido llamada también la escala de la inmadurez.

El estudio de Harris y Lingoes identificó cinco dimensiones en la escala Hy que son Negación de la ansiedad social (Hy1), Necesidad de afecto (Hy2) Sentimientos de debilidad e incomodidad (Hy3), Quejas somáticas (Hy4) e Inhibición de la agresión (Hy5).

Las quejas somáticas de la Histeria se diferencian de las de la Hipocondría en que estas últimas son más vagas e inespecíficas y no se utilizan para obtener ganancia secundaria.

Esta escala tiende a ser más alta en las mujeres que en los hombres

Las personas con puntuaciones bajas tienden a ser cáusticas, conformistas y a tener una sociabilidad disminuida y un campo estrecho de intereses.

Escala 4 (Desviación psicopática – Pd)

Esta compuesta por 50 ítemes que pretenden medir las características de las personas con desordenes psicopáticos de la personalidad y ha sido llamada la escala de la pelea.

El estudio de Harris y Lingoes describió cuatro dimensiones en la escala Pd que son Conflictos con la familia (Pd1), Conflictos con la autoridad (Pd2), Imperturbabilidad social (Pd3) y Alienación (Pd4) que incluye Alienación social y Autoalienación.

Las personas con puntuaciones elevadas son caracterizadas como amorales, asociales, despreocupadas por las normas y costumbres sociales, dificultad para aprender de la experiencia que se muestra en la repetición del mismo tipo de dificultades a pesar de las sanciones, superficialidad emocional, falta de sentido de la lealtad y de la responsabilidad.

Las puntuaciones moderadamente altas (60 – 70 T) pueden reflejar rasgos positivos como energía, asertividad, franqueza, iniciativa, dependiendo de la madurez del sujeto y de sus mecanismos de control.

Los sujetos que obtienen puntuaciones bajas en esta escala con frecuencia son descritos como convencionales, conformistas y sumisos y si estos sujetos son hombres también se dice que son poco interesados en el sexo y temerosos de las mujeres

Las puntuaciones tienen una correlación negativa con la edad, de tal modo que se espera que las personas

jóvenes tengan puntuaciones algo más elevadas que las personas mayores. Por ello es que mientras mayor sea la edad del sujeto, mayor importancia tienen las puntuaciones altas en esta escala.

Escala 5 (Masculinidad – Feminidad – Mf)

Esta escala esta compuesta de 60 ítemes que se refieren a intereses pertenecientes al estereotipo femenino y que intenta evaluar la tendencia que siguen los intereses del sujeto ya sea hacia lo masculino o hacia lo femenino.

Tanto en hombres como mujeres un puntaje alto indica una desviación del patrón de intereses hacia el del sexo contrario.

En 1971 Serkownek, basándose en el análisis factorial, describió seis dimensiones dentro de esta escala que son: Narcisismo e hipersensibilidad (Mf1), Estereotipo de intereses femeninos (Mf2), Negación del estereotipo de intereses masculino (Mf3) Incomodidad sexual y pasividad (Mf4) Introspectivo y crítico (Mf5) y Retraimiento social (Mf6).

Las puntuaciones altas en hombres pueden corresponder a homosexuales, pero existen en este caso muchos falsos positivos y negativos. Los hombres con puntuaciones altas no se identifican con el rol masculino tradicional y son caracterizados como pasivos, con inclinaciones estéticas, sensibles frente a los demás.

Las puntuaciones moderadamente altas en hombres se asocian a un rango amplio de intereses, especialmente estéticos

Las puntuaciones bajas en hombres se presentan en sujetos que aparecen como exageradamente masculinos, prefieren la acción, ponen énfasis en la fuerza y el valor y presentan una amplitud de intereses limitada.

Las mujeres que tienen puntajes altos rechazan el papel tradicional asignado a las mujeres, su patrón de intereses es más bien masculino y es descrita como competitiva, dominante, con emotividad disminuida.

Las puntuaciones de moderada elevación se asocian a mujeres cuyos intereses incluyen actividades culturalmente consideradas como masculinas como el quehacer científico, la computación, etc.

Cuando las mujeres presentan puntuaciones bajas, estas se identifican marcadamente con el patrón de intereses femeninos y son descritas como pasivas, sumisas, sensibles e idealistas. Si la puntuación es marcadamente baja son mujeres que sienten autocompasión, muy autocríticas y aparecen como desamparadas. El desamparo puede ser genuino o constituir una forma de manipular a los otros.

Escala 6 (Paranoia – Pa)

Esta compuesta por 40 ítemes cuyo propósito fue evaluar el cuadro clínico que incluye ideas de referencia, influencia y grandeza, suspicacia, hipersensibilidad y rigidez. Los ítemes se refieren desde rasgos francamente psicóticos como ideas delirantes hasta rasgos caracterológicos como la tendencia a culpar a los demás y la admisión de fragilidad psicológica y la utilización de mecanismos de proyección.

El estudio de Harris y Lingoes señalo la presencia de tres grupos de contenido dentro de la escala que son Ideas persecutorias (Pa1) Lastimero (poignancy) (Pa2) e Ingenuidad (Pa3).

Los sujetos con puntuaciones moderadamente altas pueden ser hipersensitivos, autorreferentes, moralistas y aquellos con puntuaciones altas, sobre 70, son sujetos que se caracterizan por ser suspicaces y hostiles, y que se sienten maltratados o tratados injustamente.

Las puntuaciones bajas se asocian a personas muy confiadas, poco inquisitivas

Las puntuaciones menores de 35 T tienen el mismo significado de desconfianza que las puntuaciones altas. En este caso la persona se comporta muy cautelosamente y evita las preguntas muy obvias que revelen rasgos paranoideos

Escala 7 (Psicastenia – Pt).

Esta escala contiene 48 ítems que reflejan características tales como, ansiedad, temor, baja autoestima y autoconfianza y pretende evaluar el patrón obsesivo – compulsivo. Sin embargo los ítems no se refieren específicamente a obsesiones o compulsiones, sino más bien a los rasgos caracterológicos que dan lugar a la variedad de síntomas específicos de esta alteración. Ha sido llamada la escala de la angustia.

Los sujetos que presentan puntajes altos en esta escala se caracterizan por ser tensos, indecisos, tener tendencia a la rumiación y a los sentimientos de culpa, pueden presentar pensamientos obsesivos y conducta compulsiva.

Una elevación moderada en esta escala, junto al resto de las escalas clínicas con puntajes por debajo de 70, puede estar señalando la habilidad de una persona para ser organizada, puntual y metódica

Las personas con puntaje más bien bajos son confiados en si mismos, manejan apropiadamente el stress y valoran el éxito y el reconocimiento.

Escala 8 (Esquizofrenia – Sc)

Consta de 78 ítems que cubren una amplia gama de conductas. Algunos de ellos se refieren a síntomas francamente psicóticos como delirios y alucinaciones y otros se relacionan con alteraciones de las relaciones familiares, déficit en el control de impulsos, temores e insatisfacciones.

Es necesario ser cauteloso para hacer el diagnóstico de Esquizofrenia sólo fundándose en esta escala , ya que ésta es tal vez la escala más compleja del MMPI. A pesar de que muchos esquizofrénicos obtienen puntuaciones sobre 70, también obtienen puntuaciones muy elevadas , aún de 90 T, sujetos neuróticos muy agitados, adolescentes con problemas de ajuste, personas en crisis de identidad.

En general los sujetos que obtienen puntuaciones más bien elevadas se caracterizan por tener sentimientos de alienación, sensación de ser diferentes y no ser comprendido, por tener dificultades en expresar la hostilidad.

Los puntajes moderadamente altos reflejan un tipo de intereses más bien abstractos, se encuentran en sujetos imaginativos y creativos, pero que se quedan más bien en proyectos sin llegar a concretarlos.

Los sujetos con puntajes bajos son más bien prácticos y realistas

En los adolescentes se esperan puntuaciones más altas, por lo que algunos autores recomiendan restarle 10 T al puntaje obtenido por estos sujetos para poder darle la interpretación correcta.

El estudio de Harris y Lingoes señaló la presencia de tres dimensiones: Alienación que se subdivide en Alienación Social (Sc1A) y Alienación Emocional (Sc1B), Perdida de control del Yo que se subdivide en Perdida de control del Yo cognitiva (Sc2A), Perdida de control del Yo conativa (Sc2B) Perdida de control del Yo, por déficit de inhibición (Sc2C) y Experiencias sensoriales bizarras (Sc3).

Escala 9 (Hipomanía – Ma)

Esta escala está compuesta por 46 ítemes cuyo contenido es heterogéneo. Algunos de ellos se refieren a características como expansividad, excitabilidad, actividad y otros a las relaciones familiares, actitudes morales y preocupaciones somáticas.

Los puntajes altos se encuentran en personas hiperactivas, emocionalmente lábiles y que pueden experimentar fuga de ideas. El estado de ánimo es normalmente eufórico pero puede cambiar bruscamente.

Las elevaciones moderadas se encuentran en sujetos entusiastas, activos, energéticos y gregarios y son más frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes.

Los puntajes bajos se asocian con disminución de la energía y la actividad. Puntuaciones menores de 35 indican depresión sin importar cual sea el nivel de la Escala 2

El estudio de Harris y Lingoes señaló cuatro grupos de contenido dentro de los ítemes: Amoralidad (Ma1), Aceleración psicomotora (Ma2), Imperturbabilidad (Ma3) e Hipertrofia del Yo (Ma4).

Escala 0 (Introversión Social – Si)

Contiene 70 ítemes y fue desarrollada para evaluar la tendencia a aislarse de la vida social.

Los sujetos que obtienen puntuaciones altas se caracterizan por ser tímidos, socialmente inseguros, se retraen y evitan a los otros.

Los sujetos con puntuaciones moderadamente elevadas prefieren estar solos o con pequeños grupos y con personas conocidas; son capaces de interactuar con los demás pero prefieren no hacerlo.

Aquellos sujetos que obtienen puntuaciones bajas son extrovertidos y gregarios. Las personas con puntuaciones muy bajas (menores de 35 T) pueden tener relaciones interpersonales extremadamente superficiales.

Las dimensiones de contenido por las que está compuesta la escala son: Inferioridad. Incomodidad personal (Si1) Incomodidad con los otros (Si2) Seriedad Rigidez personal (Si3) Hipersensibilidad (Si4) Desconfianza (Si5) Preocupaciones somáticas (Si6).

CARACTERÍSTICAS DE LOS PERFILES

Los perfiles pueden ser analizados de acuerdo con dos características diferentes: su **elevación** y su **configuración** que son interdependientes entre sí.

ELEVACIÓN.

La elevación de un perfil está determinada por la puntuación T de las escalas, de tal manera que mientras más alto sea el puntaje de las escalas más elevado es el perfil.

El perfil tiene una línea más gruesa en el puntaje T 50 que corresponde al promedio y una zona entre las puntuaciones T 30 y 70, zona que abarca ± 2 desviaciones del promedio, la que se conoce como zona normal.

La elevación del perfil refleja lo que Lachar llama el **principio de intensidad**, en el sentido en que mientras más alto sea el puntaje de una escala mayor es la probabilidad de que el sujeto que obtiene ese puntaje se parezca a aquellos que forman el grupo a través del cual la escala fue construida.

Por otra parte la elevación también se relaciona con la intensidad de la perturbación que percibe el sujeto y

con lo egodistónicos que siente sus síntomas. En las alteraciones de la personalidad mientras mayor es la elevación, más establecida está la patología y más resistente al cambio será

Desde el punto de vista de la elevación se distinguen los siguientes tipos de perfiles:

Normal.

Son aquellos en que todas las escalas se encuentran cercanas a la línea horizontal del T 50. Este tipo de perfil no se encuentra en la población psiquiátrica.

Sumergido.

Es considerado también de elevación normal y se caracteriza porque su punto más alto no sobrepasa o sobrepasa muy poco el T 50 y la mayoría de las puntuaciones están entre 30 y 40 T.

Limítrofe.

Este tipo de perfil se caracteriza porque tiene varias escalas entre 60 y 70 T y aún algo por sobre 70. No debe tener más de dos escalas elevadas, pero si puede tener puntuaciones por sobre 54 T.

Elevado.

Se caracteriza por tener algunas escalas en la parte alta del perfil, especialmente cuando el sujeto obtiene puntuaciones superiores a 80 T. Se puede tratar de algunas pocas escalas que se encuentran en esa zona y las otras pueden tener puntuaciones más bajas.

Un tipo especial de perfil elevado es el Flotante que se caracteriza por tener varias escalas muy elevadas, tener la escala F con puntuación entre 60 y 92 T, las escalas 1, 2 o 3 con puntuaciones superiores a 80 T y las escalas 7 y 8 con puntuaciones iguales o mayores a 85 T.

CONFIGURACIÓN.

La configuración se refiere a la forma que adquiere el perfil. De acuerdo con Lachar la configuración del perfil se relaciona con el ***principio de dominancia***, el cual señala que aquellas escalas que alcanzan las elevaciones más altas representan los rasgos más característicos de esa persona y modifican la interpretación de las otras escalas.

Algunas configuraciones de los perfiles que se han descrito son las siguientes:

Espiga.

En esta configuración la mayoría de las escalas se mantienen en un nivel semejante y una o dos escalas tienen valores marcadamente elevados.

Curva difásica.

Estos perfiles tienen dos espigas aisladas, que pueden encontrarse en cualquier lugar del perfil. A la curva difásica con elevaciones en las escalas 4 y 9 se le llama *configuración de trastorno del carácter*.

Sierra dentada

En esta configuración las escalas 8 y 6 son las escalas predominantes del perfil; las escalas 1, 2 y 3 son algo

más bajas que la escala 4 y la escala 2 es mayor que la 1 y la 3. De esta manera con las escalas 2, 4, 6 y 8 más altas, el perfil da la impresión de los dientes de una sierra.

Este perfil puede señalar un desorden psicótico severo.

Anticlinorium

En este tipo de perfil las escalas del centro son más elevadas que las escalas de los extremos. Es un perfil poco frecuente en las poblaciones clínicas y se encuentra con mayor frecuencia en las poblaciones universitarias.

Sinclinorium

Este perfil es una variante del perfil difásico y se caracteriza por tener aumentos notorios en las escalas 1 y 9, mientras que las demás escalas se mantienen uniformemente bajas. Este perfil es relativamente raro.

Inclinación negativa

Las primeras escalas son más elevadas que las últimas escalas del perfil. Cuando 1, 2, 3 y 4 aparecen más elevadas que el resto se le llama **perfil de la somatización**. Los sujetos que presentan este perfil se caracterizan por presentar ansiedad, depresión, estado de ánimo bajo, sintomatología física y no aparecen distorsiones psicóticas.

Inclinación positiva.

Las últimas escalas del perfil aparecen más elevadas que las primeras. Cuando las escalas 9, 8, 7 y 6 aparecen más elevadas que el resto se le llama **patrón hipomaniaco**. Los pacientes que presentan esta configuración se caracterizan por tener un control disminuido de los impulsos, un contacto pobre con la realidad y aún pueden tener desorientación y confusión

Inclinación 0 o natural

En este caso las escalas de los dos extremos tienen aproximadamente la misma elevación.

El perfil que tiene una elevación baja o normal y una inclinación 0 se presenta en sujetos normales, pero también puede aparecer en pacientes psicóticos crónicos, en los cuales la sintomatología se ha hecho egosintónica..

Cuando aparece una inclinación 0 y la elevación del perfil es más alta, corresponde a sujetos que son diagnosticados como Borderline.

En general, mientras más plano es el perfil, mejor ajustada está la persona, especialmente si la elevación es normal

CONFIGURACIONES DE LA TRIADA NEURÓTICA.

Las escalas 1, 2 y 3 se conocen como la **triada neurótica**.

V de conversión

En la configuración en V de conversión, las escalas 1 y 3 aparecen elevadas, generalmente sobre 70 y la escala 2 se mantiene dentro de la zona normal. Esta configuración caracteriza a las personas que transforman los problemas psicológicos en quejas somáticas. La elevación general de la V refleja la cantidad de aflicción

que la persona está experimentando y mientras más altas estén las escalas 1 y 3 en relación con la escala 2 más fuerte es la estructura defensiva que le permite no ver lo que le ocurre.

V invertida.

En este caso las escalas 1 y 3 tienen elevaciones menores que la escala 2, presentándose las escalas 1 y 3 con puntuaciones en la parte alta de la zona normal y la escala 2 con puntuaciones sobre 70.

Señala una condición neurótica crónica con sintomatología mixta. Si la escala 1 tiene puntuaciones por debajo de 70 y las escalas 2 y 3 puntuaciones por sobre 70, el sujeto se caracteriza por el sobrecontrol emocional, estar fatigado, ansioso y lleno de dudas acerca de si mismo.

Inclinación negativa dentro de la triada.

En este caso todas las escalas tienen puntuaciones T por sobre 70 y la puntuación de la escala 1 es mayor que la 2 y la de la 2 es mayor que la de la 3. Los sujetos que presentan esta configuración se caracterizan por presenta preocupaciones somáticas crónicas, hipersensibilidad frente a la menor disfunción y quejarse constantemente de molestias físicas sin que presenten ninguna patología somática. No son capaces de percibir con claridad la relación entre sus quejas de malestares físicos y algún problema psicológico.

Inclinación positiva dentro de la triada.

En esta configuración también las tres escalas deben tener puntuaciones mayores que 70 T y la escala 1 tiene puntuaciones menores que la escala 2 y ésta tiene puntuaciones menores que la escala 3.

Esta configuración es llamada el **perfil de la histerectomía** ya que se presenta con frecuencia en mujeres con una historia de quejas ginecológicas y que además reportan problemas matrimoniales y frigidez. Cuando aparece en los hombres estos se caracterizan por presentar estados crónicos de ansiedad y los efectos físicos de un stress prolongado, como úlceras gástricas, etc. Tanto en hombres como en mujeres esta configuración señala un síndrome neurótico mixto con predominio de la depresión y la somatización. También se puede presentar anorexia.

CONFIGURACIONES DE LA TÉTRADA PSICÓTICA

La tétrada psicótica está formada por las escalas 6, 7, 8 y 9.

V psicótica o Valle paranoide

Muestra elevaciones altas en las escalas 6 y 8 y las restantes escalas de la tétrada se presentan relativamente más bajas. Se presenta en sujetos que pueden ser descritos como emocionalmente retraídos, suspicaces, hostiles y con disminución del insight..

OTRAS CONFIGURACIONES CLÍNICAS.

V de Scarlett O'Hara

Esta configuración se caracteriza por elevaciones por sobre 65 T en las escalas 4 y 6 y elevaciones menores a 35 en la escala 5. No es necesario que las escalas 4 y 6 sean las escalas más altas de todo el perfil.

Esta configuración se ve con más frecuencia en mujeres. Son mujeres hostiles e iracundas, pero incapaces de expresar sus sentimientos directamente. Irritan a los demás y luego se lamentan de lo maltratadas que son por los otros. Son excesivamente demandadoras y dependientes.

Si la escala 3 es más alta que esta configuración se tratará de mujeres superficialmente sociables que niegan cualquier sentimiento hostil hacia los demás.

A esta configuración también se la llama ***síndrome pasivo – agresivo*** y en algunos textos aparece como open legs syndrome

CONFIGURACIÓN DE LAS ESCALAS DE VALIDEZ.

Escalas L y K con T menor que 50 y F con T mayor que 60.

Se trata de sujetos que admiten tener problemas y que no están seguros de su capacidad para manejar estos problemas. Sienten que requieren asistencia. Mientras más alta sea F, el sujeto experimenta más problemas, se siente peor y puede exagerar su sintomatología para obtener ayuda. Esta configuración de las escalas de validez se conoce como ***grito de ayuda***

Escalas L y K entre 50 y 60 T y F mayor que 70.

Aparece en sujetos que tienen problemas, pero al mismo tiempo se defienden de ellos; sin embargo estas defensas resultan ineficientes. Se trata de pacientes crónicamente desajustados.

Escala L con T menor que 50; escala F igual o mayor que K y la escala K esta por sobre 55 T.

El sujeto tiene problemas que se han mantenido en el tiempo, pero se ha adaptado a ellos. Puede admitirlos y al mismo tiempo se siente bien.

Escalas L y K con T mayores a 60 y la escala F es igual o menor que 50 T

El sujeto niega problemas y sentimientos e impulsos negativos. Se presenta lo mejor posible, es simplista y ve el mundo en términos polares bueno – malo. Su ajuste social será adecuado y sólo presentara desajustes leves.

Si las elevaciones de L y K aumentan, esta configuración indica escasa capacidad de insight por rigidez defensiva

Inclinación positiva ($L < F < K$; generalmente $L = 40$, $F = 50 - 55$ y $K = 60 - 70$)

Se trata de un sujeto normal que tiene recursos para enfrentar sus problemas y que no está experimentando stress o conflictos en este momento. La escala K será más o menos alta dependiendo del grupo de referencia socio cultural del sujeto.

Inclinación negativa ($L > K > F$; $L = 60$, $F = 50$, $K = 40 - 45$)

Esta configuración muestra a un sujeto ingenuo y poco sofisticado, que intenta aparentar estar bien. Este intento generalmente no le resulta y la triada neurótica aparece elevada. Si la escala F aparece más elevada, no sobrepasa los 70 T, lo que implica que el sujeto está tratando de mantener una fachada de bienestar a pesar de admitir algunos problemas.

OTROS INDICADORES.

Índice F – K.

Se calcula considerando los puntajes brutos de ambas escalas y permite también examinar la validez del perfil.

Si el Índice F – K es mayor que +9 corresponde a un perfil de falseamiento negativo, es decir el sujeto está aparentando tener alteraciones psicopatológicas.

Si el índice F – K es menor que 0 corresponde a un perfil de falseamiento positivo, vale decir que el sujeto está negando la existencia de cualquier síntoma patológico.

Cuando F – K esta entre 0 y +9 se trata de perfiles válidos.

Este índice es más eficiente para identificar perfiles de falseamiento negativo. En personas de nivel sociocultural alto no es conveniente usarlo ya que K tiende a ser más alto.

Relación entre la escala 7 y la escala 8.

Si tanto la escala 7 como la escala 8 son los puntos más elevados del perfil, aumenta la probabilidad de desorden psicótico. En este caso, si la escala 7 es mayor que la escala 8 indica que la persona está enfrentando sus problemas y usando eficientemente sus defensas.

Si la escala 7 y la escala 8 tienen puntuaciones T mayores que 75 y la escala 8 es mayor que la escala 7, indicaría que el problema es severo y la persona no esta luchando contra sus dificultades.

Cuando ambas escalas tienen puntuaciones de 70 o más y la escala 7 es mayor en 10 T que la escala 8 el sujeto presentara ansiedad e indecisión como las características predominantes. Si la escala 8 es más alta que la escala 7 el rasgo predominante será la confusión mental .

Ecuación de Goldberg ((L + Sc + Pa) – (Hy + Pt))

Para este indicador se utilizan los puntajes T corregidos con K.

Se utiliza para discriminar psicosis de neurosis.

Si el resultado de la Ecuación de Goldberg es mayor a 45 indica un perfil psicótico; si es igual o menor a 44 orienta más bien a un perfil neurótico

MODELO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.

La interpretación del M.M.P.I. así como la de cualquier test psicológico, requiere no sólo conocer a cabalidad el test mismo sino también de ser capaz de integrar una serie de conocimientos que el examinador debe tener de otras áreas de la psicología, como por ejemplo, la psicología de la personalidad, psicología del desarrollo, psicopatología, etc.

Es necesario tener presente que al interpretar una prueba de esta naturaleza el examinador está trabajando con probabilidades , de tal manera que una puntuación señala la mayor o menor probabilidad que el sujeto se parezca a aquellos a partir de los cuales se ha derivado la escala que se está considerando.

Por otra parte también es importante considerar que no todas las características que se señalan para un determinada puntuación o para una configuración específica van a corresponder al sujeto que se está evaluando y es tarea del examinador seleccionar aquellas que aparecen más apropiadas para él, integrando el resto de la información que ya ha obtenido en el test, además de otros aspectos importantes que se relacionan con el sujeto, como su motivo de consulta, edad, sexo, nivel educacional, etc.

Los diferentes autores han señalado diversos modelos de análisis e interpretación de los resultados del inventario. Algunos han desarrollado un conjunto de numerosas y complejas reglas para lograr una

interpretación integrada. En tanto que otros propugnan un enfoque más simple que se apoya como punto central de la interpretación en el par de escalas clínicas más elevadas que presenta el sujeto.

El modelo de análisis que describiremos fue elaborado por Greene y considera los siguientes aspectos.

1. Examinar el puntaje de las escalas clínicas y de validez.

Esta etapa tiene por objeto decidir si cada uno de los puntajes esta dentro de lo esperado para ese sujeto en particular, especialmente considerando criterios como sexo, edad, nivel educacional. Es importante recordar que aún un puntaje dentro del rango normativo normal puede ser considerado anormal para un sujeto determinado.

Se debe analizar cada escala y tomar nota del significado de cada uno de los puntajes y hacer predicciones acerca de las escalas siguientes sobre la base del puntaje de una escala en particular.

En esta etapa se debe considerar y aceptar cualquier hipótesis que pueda derivarse de los datos sin rechazar ninguna.

2. Examinar el conjunto de los datos entregados por las escalas de validez y las escalas clínicas.

Este proceso tiene por objeto detectar la información tanto consistente como contradictoria que entregan las escalas.

Las inferencias o hipótesis en las que coinciden varias escalas son importantes de considerar ya que pueden constituir rasgos centrales de la personalidad del sujeto.

Las contradicciones o inconsistencias, que no son infrecuentes de encontrar en el análisis de los perfiles, también son relevantes ya que deben ser resueltas en el proceso de interpretación.

3. Analizar e interpretar pares de escalas clínicas.

Esta forma de análisis es la más común que señalan los autores y la más simple para analizar grupos de escalas clínicas. Para llevar a cabo el análisis con este método algunos investigadores señalan que es necesario que ambas escalas que forman el par tengan puntajes T de 70 o más; otros autores consideran suficiente que sólo una de las escalas del par que presenta las puntuaciones más altas tenga un T de 70 o más.

Si existen diez escalas clínicas y no se considera el orden de las escalas dentro del par, ya que la evidencia empírica ha señalado que sólo en algunos pares es importante este orden, existen 45 posibles pares de escalas. Sin embargo no todos se dan con la misma frecuencia y por lo tanto no se dispone de la misma información acerca de todos ellos. Por otro lado en un principio las escalas 5 y 0 no se consideraban en la codificación, por lo que la información acerca de las combinaciones de estas escalas con otras es más escasa. También es importante considerar que se han encontrado evidencias de la influencia del sexo y la edad en la frecuencia de los pares más altos.

Una de las combinaciones más frecuentes es 13/31, la que además es más frecuente en mujeres que en hombres y más frecuente en personas mayores que en jóvenes. La combinación 12/21 no es demasiado frecuente en los normales pero es una de las más frecuentes en pacientes. El par 17/71 también es relativamente frecuente en el grupo de pacientes. La combinación 45 es más frecuente en hombres que en mujeres.

En la mayoría de los libros acerca del test se señalan numerosas características psicológicas para cada uno de los pares de escalas y el examinador debe seleccionar aquellas descripciones que considera más apropiadas,

tomando en cuenta si el orden de las escalas dentro del par determina alguna diferencia, el grupo criterio que se utilizó para construir la descripción y la elevación que presentan las escalas del par.

Esta descripción se debe comparar con las interpretaciones que ya se habían hecho de cada una de las escalas, recordando que las coincidencias afirman la importancia de una característica en la personalidad del sujeto y las contradicciones e inconsistencias deben ser resueltas.

Es necesario mencionar que en este análisis es importante considerar también las escalas clínicas más bajas, las que frecuentemente son dejadas de lado, centrando el análisis en el par más alto. Algunos autores incluso sostienen que las escalas más bajas (T 44 o menos) se relacionan con aquellas áreas de las cuales el sujeto se está defendiendo y no quiere mostrar.

4. Análisis de grupos de escalas de validez y clínicas.

En este análisis se deben examinar grupos más amplios de escalas, tales como algunos que ya se han descrito.

En este nivel de la evaluación del perfil se consideran en general algunas triadas como L, F y K; Escalas 1,2 y 3, etc.

Este análisis es más complejo ya que se debe considerar la elevación general del grupo así como la elevación relativa de cada una de las escalas que lo componen.

5. Análisis de la configuración total del perfil.

En este nivel es necesario considerar sólo las escalas clínicas y considerar como criterios de análisis aquellas características del perfil que ya se han señalado como elevación general, configuración, etc.

BIBLIOGRAFÍA

Dahlstrom, Welsh y Dahlstrom An MMPI handbook. Vol I. Clinical interpretation. University Minnesota Press. 1972.

Graham J.R. MMPI. Guía práctica. Ed. Manual Moderno. 1987

Greene R.L. MMPI. An interpretative manual Grune & Stratton. 1980.

Hermosilla Marta Introducción al estudio del Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota. Manuales de Psicología. Pontificia Universidad Católica de Chile. 1987.

Lachar D. The MMPI. Clinical assessment and automateinterpretation. Western Psychological Services. 1993.

Núñez Rafael Aplicación del MMPI a la psicopatología. Ed. Manual Moderno. México. 1994.

Núñez Rafael Manual práctico del MMPI. Ed. Trillas. 1996.

TABLA DE CONVERSION A PUNTAJES T PARA PUNTAJES CORREGIDOS CON K. HOMBRES

TABLA DE CONVERSION A PUNTAJES T PARA PUNTAJES CORREGIDOS CON K. MUJERES

TABLAS DE CONVERSION A PUNTAJES T PARA PUNTAJES NO CORREGIDOS CON K